

PEMBERDAYAAN KELUARGA DENGAN LITERASI KESEHATAN DALAMPENCEGAHAN PENYAKIT STROKE

Andi Parellangi • Bisepta Prayogi
Ria Roswita



Pemberdayaan Keluarga dengan Literasi Kesehatan Dalam Pencegahan Penyakit Stroke

Dr. Andi Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep., M.H.

Bisepta Prayogi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ria Roswita, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Pemberdayaan Keluarga Dengan Literasi Kesehatan
Dalam Pencegahan Penyakit Stroke**

Penulis: Dr. Andi Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep., M.H.
Bisepta Prayogi, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ria Roswita, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7097-77-4

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Pemberdayaan keluarga dengan literasi kesehatan dalam pencegahan penyakit stroke / Dr. Andi Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep., M.H., Bisepta Prayogi, S.Kep., Ns., M.Kep., Ria Roswita, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
75 halaman : ilustrasi ; 30 cm
ISBN 978-634-7097-77-4
Kesehatan keluarga
614 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1183533>

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, hikmat, dan kesempatan sehingga buku ini, yang berjudul **"Pemberdayaan Keluarga dengan Health Literacy dalam Pencegahan Penyakit Stroke"**, dapat terselesaikan. Buku ini lahir dari kepedulian kami terhadap pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan literasi kesehatan untuk mencegah salah satu penyakit yang paling mematikan dan berdampak besar secara sosial maupun ekonomi, yaitu stroke.

Penyakit stroke bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi tantangan bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, literasi kesehatan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat, deteksi dini, serta pengelolaan risiko penyakit stroke. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi keluarga untuk memahami konsep literasi kesehatan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyusun buku ini dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai aspek kesehatan, seperti pola makan, aktivitas fisik, manajemen stres, hingga pemahaman terhadap faktor risiko genetik dan lingkungan. Selain itu, kami berupaya untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami, berbasis bukti, dan aplikatif sehingga dapat menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, pakar kesehatan, dan keluarga yang memberikan inspirasi, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya pencegahan stroke, memperkuat literasi kesehatan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca, semoga buku ini menjadi bekal yang berharga dalam menjaga kesehatan keluarga Anda.

(Desember, 2024)

Penulis

Daftar Isi

Prakata..... iii

Daftar Isi..... v

Bab 1 Pendahuluan 1

Bab 2 Pemberdayaan Keluarga..... 9

A. Pengertian Pemberdayaan Keluarga 9

B. Tujuan Pemberdayaan Keluarga 10

C. Manfaat Pemberdayaan Keluarga 12

D. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Keluarga 13

E. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Keluarga..... 14

F. Ruang Lingkup Pemberdayaan Keluarga 15

G. Intervensi Pemberdayaan Keluarga 19

Bab 3 Literasi Kesehatan..... 21

A. Pengertian Literasi Kesehatan..... 21

B. Kerangka Konsep Literasi Kesehatan..... 22

C. Komponen Literasi Kesehatan 23

D. Bidang Literasi Kesehatan..... 24

E. Manfaat Literasi Kesehatan 26

F. Klasifikasi Literasi Kesehatan 29

G. Tingkatan Literasi Kesehatan..... 30

H. Tindakan Literasi Kesehatan 31

Bab 4 Stroke..... 39

A. Pengertian Stroke 39

B. Jenis Stroke 39

C. Etiologi Stroke..... 40

D. Faktor Risiko Stroke 41

E. Patofisiologi Stroke 43

F. Manifestasi Klinik Stroke	45
G. Pengelolaan Stroke	46
H. Pencegahan Primer Stroke	48
Bab 5 Penutup	50
Daftar Pustaka	53
Glosarium	63
Profil Penulis	66

Bab 1

Pendahuluan

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit (UU Kep No 14, 2014, Parellangi, A., 2018). Perawat sebagai tenaga Kesehatan yang profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif dalam membantu klien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik. Perawat memandang klien sebagai makhluk bio-psiko-sosiokultural dan spritual yang berespon secara holistik dan unik terhadap perubahan kesehatan yang dialaminya. Salah satu masalah yang dialami klien adalah masalah kesehatan penyakit tidak menular seperti stroke.

Stroke merupakan penyakit terbanyak dan penyebab utama kematian dan juga memberikan dampak kecacatan dengan angka kejadian yang semakin meningkat setiap tahunnya di dunia termasuk Indonesia. Stroke yang menyebabkan kematian diperlukan tindakan pencegahan atau deteksi dini risiko stroke kepada masyarakat, dan penanganan awal dalam kondisi akut atau serangan stroke, serta juga kecacatan akibat komplikasi medis atau gejala sisa pascastroke, disamping juga memerlukan waktu jangka panjang untuk pemulihan, hingga di masa yang akan datang

membutuhkan biaya yang sangat mahal terkait rangkaian perawatan, pengobatan dan terapi rehabilitasi yang dijalani oleh pasien penyakit stroke. Sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi pasien maupun keluarga pasien dan juga menjadi beban bagi Negara (Dharma et al., 2018; Mei et al., 2020; Veras et al., 2020).

Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan adalah sebesar 7 per mil dan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala adalah sebesar 12,1 per mil pada populasi 15 tahun keatas. Angka ini belum dilihat berdasarkan variabel lain seperti tipe daerah. Jika dilihat penyebarannya berdasarkan tipe daerah, prevalensi stroke di daerah perkotaan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan adalah sebesar 8,2 per mil dan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala adalah sebesar 12,7 per mil. Prevalensi stroke di daerah rural berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan adalah sebesar 5,7 per mil dan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala adalah sebesar 11,4 per mil (Marlina et al., 2020).

Data Riskesdas (2018), menyatakan bahwa prevalensi stroke (permil) berdasarkan diagnosa dokter provinsi dengan penderita stroke tertinggi ada pada Provinsi Kalimantan Timur merupakan 14,7 per mil. Beban akibat penyakit stroke (*burden of disease*) semakin meningkat akibat angka kekambuhan yang tinggi. Menurut American National Stroke Association dalam Dharma, et al (2018) menunjukkan bahwa jumlah serangan stroke berulang satu bulan paska serangan stroke pertama berkisar antara 3-10%, setelah satu tahun meningkat menjadi 514%, dan setelah 5 tahun menjadi 25-40%. Sementara di Indonesia, serangan stroke berulang setelah satu tahun terjadi pada 19,9 % pasien setelah serangan stroke pertama, setelah

lima tahun meningkat menjadi 24% pada perempuan dan 42% pada laki-laki untuk semua kelompok usia.

Beban utama akibat stroke disebabkan oleh gejala sisa berupa disabilitas fisik akibat gangguan sistem syaraf yang berlangsung dalam waktu lama. Dobkin (2005) membuktikan bahwa 35% pasien paska stroke dengan paralisis tidak mendapatkan fungsi normalnya kembali, 20-25% pasien tidak dapat berjalan tanpa bantuan fisik enam bulan setelah serangan stroke dan sekitar 65% pasien tidak dapat menggunakan tangan yang lemah untuk beraktivitas. Pasien yang selamat dari serangan stroke hampir semua mengalami keterbatasan fisik pada 3 bulan pertama setelah serangan. Pengukuran kemampuan fungsional tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan pada 3-4 bulan setelah stroke dan hanya 25% pasien kembali normal (Dobkin, 2005).

Beban stroke semakin berat jika pasien mengalami masalah psikologis seperti depresi. Kong et al (2006) membuktikan bahwa 24% pasien stroke mengalami depresi yang dapat menurunkan kualitas hidup terutama pada domain keterbatasan peran, kesehatan general, fungsi sosial dan status mental. Disabilitas fisik dan depresi menyebabkan penurunan produktifitas dan kualitas hidup paska stroke. (Patel, M.D., Tilling, K., Lawrence, 2006) membuktikan bahwa ketidakmampuan merawat diri dan keterbatasan aktivitas menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Kualitas hidup pasien yang diukur dengan alat ukur *short form 36* (rentang skor 0-100) setelah satu tahun serangan stroke menunjukkan rerata sebesar 37,1 dan setelah tiga tahun hanya sebesar 37,9 (Patel, M.D., Tilling, K., Lawrence, 2006). Penurunan kualitas hidup berhubungan signifikan dengan depresi dan disabilitas fisik (Artal, J.C., et al, 2000).

Peningkatan jumlah pasien stroke, penurunan kualitas hidup dan perawatan dalam jangka waktu lama menyebabkan beban ekonomi yang signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Biaya untuk perawatan dan pengobatan stroke mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi semua biaya untuk perawatan di rumah sakit, biaya dokter dan tenaga kesehatan lainnya, biaya perawatan di rumah, obat-obatan dan alat medik untuk menunjang aktivitas. Biaya tidak langsung meliputi hilangnya produktivitas akibat morbiditas dan mortalitas (Demaerschalk, B.M., et al, 2010). Serangan stroke yang dialami pasien juga meningkatkan beban keluarga seperti beban tenaga dan waktu untuk merawat pasien, beban finansial dan kehilangan aktifitas rutin di luar rumah. Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan total biaya langsung dan tidak langsung akibat stroke selama tahun 2008 diperkirakan sebesar 65,5 miliar dollar US. Biaya langsung berkontribusi sebesar 67% dari total biaya, sedangkan sisanya 33% berasal dari biaya tidak langsung (Demaerschalk, B.M., et al, 2010).

Pembiayaan kesehatan yang disiapkan pemerintah melalui asuransi kesehatan BPJS tidak akan mencukupi jika penyakit tidak menular dan degeneratif seperti penyakit stroke ini tidak dikendalikan dan dicegah. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) meningkat namun BPJS kesehatan tetap defisit dalam membiayai pengobatan masyarakat. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan mengatakan, terpenuhinya target kepesertaan hingga akhir tahun 2018 tidak dapat menutupi defisit yang tahun 2017 yang mencapai Rp 9,75 triliun (Fauzia, 2018).

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan beberapa program untuk menangani faktor risiko stroke melalui pos binaan terpadu

(posbindu) meliputi pengukuran tekanan darah, skrining awal penyakit tidak menular untuk usia produktif, pemberian edukasi tentang penyakit tidak menular termasuk hipertensi, diabetes mellitus dengan metode ceramah dan leaflet serta pemberian rujukan ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Namun kegiatan ini belum memaksimalkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk seperti apa yang diharapkan dalam kegiatan tersebut, karena banyaknya masyarakat yang tidak mengontrol tekanan darahnya baik ke Posbindu maupun ke Puskesmas, terutama masyarakat yang sudah didiagnosa hipertensi tetapi tidak merasakan adanya gejala hipertensi dan menganggap dirinya masih dalam keadaan sehat, sehingga merasa tidak perlu untuk memeriksakan diri (Puskesmas Sekolah Darat, 2022).

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat pada masyarakat yang berisiko terjadinya stroke, yaitu pendekatan keluarga. Menurut Kurniati et al (2020), Perlu ada dukungan yang sangat tepat sebagai sumber dukungan utama yaitu keluarga. Keluarga berperan sebagai fasilitator dalam pencegahan risiko stroke pada anggota keluarga, memastikan obat anti hipertensi diminum secara teratur dan memberikan dukungan emosional. (Kurniawati et al., 2020; López Espuela et al., 2018). Keluarga perlu diberdayakan seoptimal mungkin dalam mencegah dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi pada kondisi kesehatannya, sehingga tercapai kualitas hidup yang optimal. Dalam rangka memberdayakan keluarga, maka pengetahuan keluarga tentang penyakit stroke dan keterampilan dalam membantu pasien beradaptasi harus ditingkatkan. Intervensi model adaptasi berbasis pemberdayaan keluarga merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan

kualitas hidup pasien paska stroke melalui upaya pemberdayaan keluarga (Scheffler & Mash, 2020).

Salah satu bentuk atau metode yang diharapkan dapat digunakan adalah dengan pendekatan literasi kesehatan, yang mana metode ini dalam pemberian pendidikan kesehatan bertujuan bukan hanya untuk mengubah perilaku gaya hidup tetapi juga untuk mencapai kesadaran akan pentingnya pengaruh kesehatan dalam kehidupan yang berkualitas, memotivasi individu dan keluarga untuk bertindak dalam mengatasi masalah kesehatannya. Literasi kesehatan pada setiap individu dan keluarga penting untuk diketahui karena berhubungan dengan kemampuan untuk memperoleh informasi kesehatan, meningkatkan pengetahuan kesehatan serta membantu individu dan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesehatan (Jones, C.A. et al, 2011). Menurut (Sorensen, et al, 2012) proses literasi kesehatan akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memiliki 3 domain dari kontinum kesehatan; menjadi sakit atau sebagai pasien, sebagai orang yang berisiko mengalami sesuatu penyakit, atau sebagai individu yang mampu mempromosikan kesehatan di masyarakat. Melalui langkah-langkah dari literasi kesehatan yang terdapat di masing-masing tiga domain (mencari informasi, memahami dan mempraktikkan), diharapkan akan melengkapi individu untuk mandiri mengelola kesehatannya.

Rendahnya literasi kesehatan membuat pasien kesulitan dalam mengingat dan memahami sebagian besar informasi yang diberikan selama melakukan konsultasi kesehatan (Wallace, 2010; Willens, et al, 2012). Literasi kesehatan yang rendah juga dikaitkan dengan pengendalian penyakit kronis yang lebih buruk (Willens et al; 2013). Dibutuhkan strategi yang

tepat untuk meningkatkan literasi kesehatan pasien agar terjalin komunikasi yang lebih efisien antara petugas dengan pasien (Tang, Y.H. Pang, et al, 2008). Beberapa pakar literasi kesehatan merekomendasikan untuk menggabungkan berbagai strategi yang efektif dan layak guna memajukan komunikasi dan pemahaman pasien selama interaksi. Strategi yang biasa digunakan seperti menggunakan bahasa sederhana, penggunaan media bergambar, aplikasi *mobile (smartphone)* dalam pendidikan kesehatan atau menerapkan model teori kesehatan untuk mempromosikan perilaku kesehatan kepada pasien hipertensi dan stroke (Javadzade, et al, 2018). Penggunaan teknologi informasi (*smartphone*) telah terbukti memberikan banyak manfaat dalam manajemen stroke diantaranya pengenalan stroke, transport dan triase pasien, penatalaksanaan kedaruratan stroke di rumah sakit, dan rehabilitasi pasca stroke. Sistematis review oleh Nam et al (2013) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk penatalaksanaan stroke mulai dari tahap akut sampai rehabilitasi. Peningkatan teknologi informasi kedepan diarahkan untuk meningkatkan upaya pencegahan stroke.

Penelitian sebelumnya mengemukakan berbagai model teori perilaku kesehatan yang dinilai efektif dalam mempengaruhi perilaku individu dalam mencegah, mengatasi dan mengendalikan permasalahan kesehatan meliputi teori Transtheoretical model (Prochaska, 2008), teori Health Belief Model (Becker et al., 1980) dan teori planned behaviour (Fishbein dan Ajzen, 1980). Berdasarkan hasil studi tersebut, pedoman atau petunjuk yang baik telah disediakan untuk merancang intervensi yang berkaitan dengan permasalahan perilaku kesehatan pada individu, namun memiliki kelemahan dengan tidak mengidentifikasi *support system* pada individu

yaitu keluarga dalam mencegah, mengatasi dan mengendalikan permasalahan kesehatan pada anggota keluarga.

Bab 2

Pemberdayaan Keluarga

A. Pengertian Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata daya (*power*) yang artinya kekuatan berasal dari dalam (Ardian, 2014). Secara konseptual pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga, terutama keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang belum dapat mencapai tujuan hidup berkeluarga. Menurut Capacity Building Center for States, (2019), pengertian pemberdayaan keluarga adalah tindakan melibatkan, melibatkan, dan mengangkat di seluruh bidang kesejahteraan anggota keluarga dengan mendorong keluarga untuk mengambil peran aktif dalam berpartisipasi dengan kesejahteraan anggota keluarga. Dengan kata lain memberdayakan keluarga adalah memungkinkan dan memandirikan keluarga. Keberdayaan keluarga merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu keluarga untuk bertahan, dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuannya. Pemberdayaan keluarga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam memandirikan klien dalam mengontrol status kesehatannya.

Proses sosial dalam mengenal, mempromosikan dan meningkatkan kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya sendiri dan memobilisasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mengontrol hidup mereka. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam melakukan tugas kesehatan keluarga dan mampu menggunakan sumber daya atau potensi yang dimilikinya sehingga mampu beradaptasi dan mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan pada anggota keluarganya. Hal ini diharapkan akan munculnya perilaku adaptif dalam keluarga.

Perilaku adaptif yang dipengaruhi oleh dukungan sosial untuk individu dari berbagai usia (J. A. Price et al., 2018). Perilaku adaptif keluarga mencakup keterampilan konseptual, keterampilan sosial dan keterampilan praktis dalam mengatasi masalah kesehatan (Tassé & Balboni, 2020). Keterampilan konseptual meliputi keterampilan akademik, komunikasi, dan kemampuan individu dalam mengarahkan diri sendiri. Keterampilan sosial meliputi keterampilan interpersonal, tanggung jawab sosial, perilaku disiplin. Keterampilan praktis meliputi kebersihan diri sendiri, kemandirian, berumah tangga, manajemen uang, keterampilan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Anggota Keluarga berbagi ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan keluarga (Capacity Building Center for States, 2019).

B. Tujuan Pemberdayaan Keluarga

Menurut Hasanah et al., (2015), pemberdayaan keluarga memiliki dimensi tujuan yang luas dan beragam yaitu:

1. Membantu sasaran untuk menerima/ melewati/ menjalani/ mempermudah proses perubahan yang harus/ akan dijalani/ ditemui individu/ keluarga.
2. Menggali kapasitas/ potensi laten anggota keluarga.
3. keterampilan manajerial dan keterampilan kepemimpinan).
4. Mendorong sasaran agar memiliki daya ungkit / daya lompat serta sebagai lecutan untuk lari mengejar cita-cita keluarga.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup seluruh anggota keluarga sepanjang tahap perkembangan dan siklus hidupnya.
6. Membangun daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan agar mampu menjalani kehidupan dengan sukses tanpa kesulitan dan hambatan yang berarti.
7. Membina dan mendampingi proses perubahan sampai pada tahap kemandirian dan tahapan tujuan yang dapat diterima.

Sedangkan menurut Faster Capital, (2024), pemberdayaan keluarga bertujuan untuk:

1. Memperkuat komunikasi, pemberdayaan keluarga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam unit keluarga.
2. Membangun ketahanan, pemberdayaan juga melibatkan pembekalan keluarga dengan keterampilan dan ketahanan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan
3. Mempromosikan kemandirian finansial, pemberdayaan keluarga termasuk memberikan peluang bagi stabilitas dan kemandirian finansial.

4. Meningkatkan keterampilan mengasuh anak, pemberdayaan keluarga juga berfokus pada mendukung peran orang tua sebagai pengasuh.
5. Mendorong keterlibatan masyarakat, pemberdayaan keluarga tidak hanya mencakup rumah tangga dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat.

C. Manfaat Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga dapat memberikan banyak manfaat bagi orang tua dan anak, antara lain Dewi & Sumarni, (2023):

1. Peningkatan pengetahuan: Orang tua dapat belajar lebih banyak tentang kebutuhan anak-anaknya.
2. Mengurangi stres: Orang tua dapat mengalami lebih sedikit stres.
3. Peningkatan fungsi keluarga: Keluarga dapat berfungsi lebih baik.
4. Peningkatan perkembangan anak: Anak-anak dapat mengalami peningkatan perkembangan emosional, sosial, dan fisik.

Menurut (Youth.gov, 2024), pemberdayaan keluarga dapat meningkatkan capaian anak. Hal ini disebabkan bahwa keterlibatan keluarga terbukti dapat menghasilkan prestasi anak menjadi lebih baik, meningkatkan kedisiplinan serta anak lebih sedikit mendapatkan masalah. Selain itu, pemberdayaan keluarga juga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga, kemampuan individu serta hubungan keluarga (Mardhiyah et al., 2022). Selain itu, pemberdayaan keluarga juga mampu meningkatkan kesadaran anggota keluarga terhadap kekuatan dan kesadaran akan hak masing-masing anggota keluarga (Martínez-Rico et al., 2022)

D. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Keluarga

Menurut Hasanah et al., (2015), kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama sebagai berikut;

1. Penumbuh kembangan kesempatan
Penumbuh kembangan kesempatan merupakan kemauan, dan kemampuan keluarga untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan keluarga secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasil dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
2. Pengembangan kesempatan individu
Pengembangan kapasitas individu merupakan organisasi dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Kapasitas disini bukan sesuatu hal yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.

Menurut (Faster Capital, 2024), intervensi pemberdayaan keluarga terdiri dari:

1. Program Pendidikan Keluarga
Program pendidikan orang tua menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan penerapan

praktis. Program-program ini memberdayakan orang tua dengan memberikan informasi yang dibutuhkan keluarga.

2. Akses Sumber Daya

Akses pada sumber daya diperlukan untuk memastikan keluarga mendapatkan kemudahan akses terhadap informasi yang relevan.

3. Jaringan Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga diperlukan dalam pemberdayaan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan membina hubungan antar orang tua dan menciptakan rasa kebersamaan

4. Advokasi Keluarga

Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada keluarga saja tetapi diperlukan juga melakukan advokasi kepada pihak yang mendukung pemberdayaan keluarga.

E. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Keluarga

Menurut Ardian, (2014), agar pemberdayaan keluarga dapat tercapai, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip penting pemberdayaan keluarga. Beberapa prinsip penting tersebut diantaranya:

1. Pemberdayaan keluarga hendaknya tidak memberikan bantuan atau pendampingan yang bersifat *charity* yang akan mendatangkan ketergantungan dan melemahkan, melainkan bantuan, pendampingan dan atau pelatihan yang mempromosikan *self reliance* dan meningkatkan kapasitas sasaran pemberdayaan.
2. Hendaknya menggunakan metode pemberdayaan yang menjadikan pihak yang dibantu/dibina/didamping menjadi lebih kuat melalui latihan daya juang/tahan, menghadapi masalah atau kenelangkaan.

3. Meningkatkan partisipasi yang membawa pihak yang diberdayakan meningkat kapasitasnya.
4. Menjadikan pihak yang diberdayakan mengambil kontrol penuh, pengambilan keputusan penuh dan tanggungjawab penuh untuk melakukan kegiatan yang akan membawanya menjadi lebih kuat.

Menurut (NSW Health, 2022), prinsip dalam pemberdayaan adalah:

1. Bersikap hormat dan tidak menghakimi
2. Membangun hubungan di mana orang tersebut merasa nyaman untuk mendiskusikan perasaannya dan apa yang diinginkannya
3. Berfokus pada kekuatan dan kemampuan
4. Mendukung dan mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan
5. Menghormati keputusan yang dibuat seseorang tentang hidupnya sendiri.

F. Ruang Lingkup Pemberdayaan Keluarga

Menurut Ardian, (2014), ruang lingkup substansi pemberdayaan keluarga meliputi berbagai wilayah dan ranah utama terkait kehidupan keluarga sebagai berikut:

1. Ketahanan Keluarga

Pemberdayaan keluarga menekankan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta peningkatan kapasitas keluarga dalam kaitannya dengan kondisi dinamik suatu keluarga yang harus memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan secara fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan

kesejahteraan lahir dan bathin. Peningkatan ketahanan keluarga meliputi ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan konsep besar kehidupan yang didalamnya meliputi konsep keberfungsian keluarga, interaksi dalam keluarga, pengelolaan, stres keluarga, kelentingan keluarga, kesejahteraan keluarga yang meliputi seluruh tahap perkembangan keluarga dan akan berdampak terhadap hubungan timbal balik antara keluarga dengan lingkungannya (ekologi keluarga) (Ardian, 2014).

2. Keberfungsian, peran dan tugas keluarganya

Pemberdayaan keluarga menekankan pada peningkatan potensi dan kapasitas keluarga dalam memenuhi fungsinya seperti dinyatakan Resolusi Majelis Umum PBB bahwa: keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera. Agar fungsi keluarga berada pada kondisi optimal, perlu peningkatan fungsional dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran dimana keluarga sebagai sistem sosial terkecil dibangun (Ardian, 2014).

Peran keluarga merupakan kunci utama keberhasilan keberfungsian keluarga (*families first-key to successful family functioning*). Tugas dasar keluarga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga hari ke hari, yaitu meliputi penyediaan kebutuhan dasar anggota keluarga, menjalani dengan sukses tugas perkembangannya, sementara itu terdapat lima peran

utama keluarga bagi efektifnya fungsi keluarga yaitu penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan keluarga untuk tumbuh dan berkembang, dukungan, pengasuhan dan kasih sayang, pengembangan keterampilan hidup, pemeliharaan dan pengelolaan sistem keluarga dan kepuasan seksual suami istri (Ardian, 2014).

3. Sumber Daya Keluarga

Sumber daya bermakna sebagai sumber dari kekuatan, potensi dan kemampuan untuk mencapai suatu manfaat dan tujuan. Sumber daya merupakan asset yaitu sesuatu apapun baik yang dimiliki atau yang dapat diakses, yang dapat memberikan nilai tukar untuk mencapai tujuan. Asset tersebut bisa berupa sumber daya ekonomi, potensi manusia, karakter pribadi, kualitas lingkungan, sumber daya alam dan fasilitas masyarakat (Ardian, 2014). Sumber daya keluarga ditinjau dari sudut pandang ekonomi merupakan alat atau bahan yang tersedia dan diketahui fungsinya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan keluarga. Sumber daya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang dapat diukur, nyata secara fisik dan yang tidak dapat diukur (*intangible*) seperti integritas dan kepercayaan. Sumber daya terbagi tiga kelompok yaitu sumber daya manusia meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik serta sumber daya waktu, sumber daya ekonomi seperti pendapatan, kesehatan, keuntungan pekerjaan dan kredit dan sumber daya lingkungan meliputi lingkungan fisik, sumber daya sosial serta lembaga politik (Ardian, 2014).

Berdasarkan pengertian sumber daya tersebut, maka sumber daya keluarga dapat diartikan sebagai apa yang dimiliki dan dikuasai individu dalam keluarga baik

bersifat fisik material dan maupun non fisik, dapat diukur maupun tidak dapat diukur, sumber daya ekonomi, manusia maupun lingkungan disekitar keluarga untuk mencapai tujuan keluarga itu sendiri. Sumber daya keluarga dimaksudkan agar keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik keluarga. Kebutuhan fisik sering diasosiasikan dengan kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Ardian, 2014).

4. Interaksi dan Komunikasi Keluarga

Interaksi keluarga dapat dipandang melalui pendekatan, diantaranya pendekatan sistem yang meliputi *husband-wife interaction (marital relationship)*, *parent-child interaction*, *sibling interaction*, *intergeneration interaction*. Kajian interaksi keluarga didasari teori keluarga sebagai institusi penting bagi kehidupan individu dan pembangunan harmoni sosial. Interaksi keluarga dipandang sebagai proses yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang (kesejahteraan, karakter pribadi dan keberhasilan seseorang), yang pada akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi sistem sosial yang luas.

Mengkaji secara spesifik pola dan keragaman interaksi antara anggota keluarga (suami-istri, orang tua-anak, antar anak dan antar generasi dalam keluarga), terutama berkaitan dengan dampak perubahan sosial, serta kajian mutakhir pola interaksi yang efektif untuk menghindari, meminimalkan atau resolusi konflik antara anggota keluarga. Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi

dilakukan dengan menyatakan kebutuhan satu pihak dan mendengarkan kebutuhan pihak lain (Ardian, 2014).

G. Intervensi Pemberdayaan Keluarga

Pada tahun 1988, Dunst dan Trivette mengemukakan teori pemberdayaan keluarga sebagai intervensi keperawatan dengan menyajikan model intervensi berdasarkan tiga komponen utama pemberdayaan yang berasal dari pengamatan ilmiah dan sintesa literatur (Ardian, 2014).

1. Komponen pertama; ideologi pemberdayaan
Menjelaskan bahwa semua individu dan keluarga menyakini memiliki kekuatan dan kemampuan serta kapasitas untuk menjadi kompeten.
2. Komponen kedua; partisipasi pengalaman
Proses membangun kekuatan dari kelemahan yang ada secara benar, komponen ini merupakan bagian dari model intervensi keluarga.
3. Komponen ketiga; hasil pemberdayaan
Komponen ini terdiri dari perilaku yang diperkuat atau dipelajari, penilaian terhadap peningkatan pengawasan misal; konsep diri dan motivasi instrinsik.

Menurut Fuster Capital, (2024), intervensi pemberdayaan keluarga terdiri dari:

1. Pengetahuan dan Pendidikan
Pemberdayaan dimulai dengan pengetahuan dan keluarga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi serta memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam keluarga.

2. Kolaborasi dan advokasi
Keluarga dapat melakukan kolaborasi dengan sistem pendidikan, layanan kesehatan dan layanan sosial yang bertujuan untuk menghubungkan keluarga dengan profesional, terapis dan pendidik yang relevan.
3. Ketangguhan dan Pemeliharaan Diri
Ketangguhan dan pemeliharaan diri dapat ditingkatkan dengan lokakarya dan kelompok dukungan, praktik perawatan diri, manajemen stres dan pembangunan ketahanan.
4. Menavigasikan Perubahan
Perubahan hidup seperti mulai bersekolah, beralih ke masa dewasa, atau pindah ke rumah baru dapat menjadi hal yang menakutkan bagi keluarga. Sehingga diperlukan panduan selama masa-masa kritis ini, memastikan perubahan dapat terjadi dengan lancar pada keluarga.
5. Merayakan Perkembangan dan Kemenangan Kecil
Pemberdayaan terletak pada pengakuan perkembangan yang terjadi, tidak peduli seberapa kecilnya. Merayakan pencapaian yang baik diperlukan ketika anggota keluarga menguasai strategi perilaku baru.

Bab 3

Literasi Kesehatan

A. Pengertian Literasi Kesehatan

Pengertian literasi secara konvensional diartikan sebagai seperangkat keterampilan membaca, menulis dan berhitung, literasi kini dipahami sebagai sarana identifikasi, pemahaman, interpretasi, kreasi, dan komunikasi di dunia yang semakin digital, termediasi teks, kaya informasi dan cepat berubah (WHO, 2024). Secara umum literasi adalah suatu rangkaian pembelajaran dan kemahiran dalam membaca, menulis dan menggunakan angka sepanjang hidup dan merupakan bagian dari serangkaian keterampilan yang lebih besar, yang mencakup keterampilan digital, literasi media, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global serta keterampilan khusus pekerjaan (WHO, 2024).

Literasi kesehatan merupakan konsep yang relatif baru dalam promosi kesehatan. Ini adalah istilah gabungan untuk menggambarkan berbagai hasil dari pendidikan dan komunikasi kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mendefinisikan literasi kesehatan sebagai sejauh mana seseorang memiliki kapasitas untuk memperoleh, berkomunikasi, memproses dan memahami informasi dan layanan kesehatan dasar untuk membuat Keputusan kesehatan yang tepat (Conard, 2019; Liu et al., 2020).

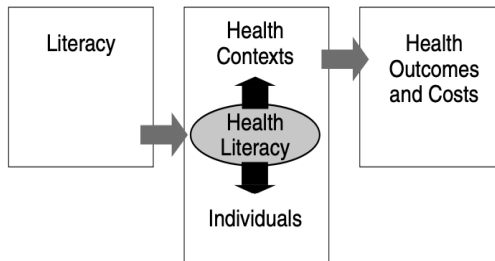
Menurut Ratzan dan Parker (2000) dalam Nielsen-Bohlman et al., (2004), literasi kesehatan adalah kemampuan individu untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi dan layanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan kesehatan pribadi. Selain itu, literasi kesehatan juga didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, yang membuat penerima literasi kesehatan mampu secara kritis menentukan perilaku kesehatan yang tepat.

Kemampuan yang dimiliki untuk membuat pilihan perilaku kesehatan, individu dituntut mampu dalam hal pengetahuan, keterampilan dan melakukan perilaku terencana seperti, mengelola, memilih, dan menyiapkan tindakan kesehatan (Chisholm-Burns et al., 2018; Conard, 2019; Liu et al., 2020). Literasi kesehatan memerlukan pengetahuan, motivasi dan kompetensi orang untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari tentang perawatan kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup selama perjalanan hidup (Tavousi et al., 2020).

B. Kerangka Konsep Literasi Kesehatan

Setiap individu kemampuan mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, berkreasi dan berkomunikasi yang dipengaruhi beberapa faktor. Apabila kemampuan tersebut berhubungan dengan kesehatan maka hal ini disebut dengan literasi kesehatan. Literasi kesehatan merupakan penghubung antara individu dengan konteks kesehatan. Setiap individu memiliki faktor-faktor konteks kesehatan seperti; kemampuan kognitif, kemampuan sosial,

status emosional dan keadaan fisik. Literasi menciptakan kemampuan individu untuk memahami dan mengkomunikasikan informasi kesehatan. Apabila literasi kesehatan ini berjalan dengan baik maka akan tercipta tujuan kesehatan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Literasi Kesehatan

Sumber: Nielsen-Bohlman et al., (2004)

C. Komponen Literasi Kesehatan

Literasi kesehatan terdiri dari dua komponen yaitu komponen literasi kesehatan individu dan literasi kesehatan lingkungan (Cox et al., 2014). Kedua komponen tersebut mempengaruhi kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menilai dan menerapkan informasi kesehatan yang didapat. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 3.2.



Gambar 3.2 Komponen Literasi Kesehatan

Sumber: (Parker, 2009 dalam Cox et al., 2014)

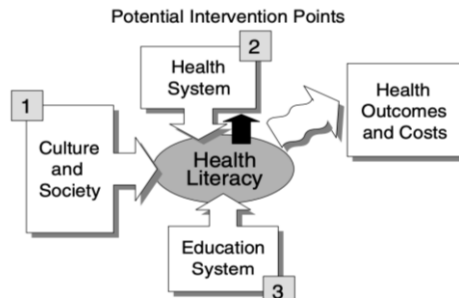
Komponen literasi kesehatan individu terdiri keterampilan, pengetahuan, motivasi dan kapasitas seseorang untuk mengakses, memahami, menilai dan menerapkan informasi agar efektif keputusan tentang kesehatan dan perawatan kesehatan dan mengambil tindakan yang tepat. Sedangkan komponen literasi kesehatan lingkungan terdiri dari infrastruktur, kebijakan, proses, materi, orang dan hubungan yang membuat meningkatkan sistem kesehatan dan berdampak pada cara orang mengakses, memahami, menilai dan menerapkan informasi yang berhubungan dengan kesehatan (Cox et al., 2014). Komponen tersebut mempengaruhi kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kesehatan. Tugas kesehatan tersebut terdiri dari :

1. Membaca, memahami dan bertindak pesan kesehatan preventif, layanan kesehatan rencana, instruksi pengobatan dan lainnya informasi kesehatan.
2. Mengisi formulir kesehatan dan perawatan kesehatan tersebut seperti formulir persetujuan, formulir asuransi, formulir klaim dan alat survei diagnostik.
3. Menemukan penyedia atau layanan kesehatan dan membuat janji.
4. Membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan dan perawatan kesehatan.
5. Menavigasi sistem dan layanan kesehatan.
6. Memahami papan petunjuk dan menemukan jalan di dalamnya dan antar layanan kesehatan.

D. Bidang Literasi Kesehatan

Bidang literasi kesehatan terdiri tiga sektor antara lain sektor budaya dan masyarakat, sistem kesehatan serta sistem pendidikan (Cox et al., 2014). Bidang tersebut menjadi wadah

intervensi pelaksanaan literasi kesehatan. Sehingga hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang meningkatkan literasi kesehatan.



Gambar 3.3 Bidang Literasi Kesehatan

Sumber: (Nielsen-Bohlman et al., 2004)

Pada Gambar 3.3 menggambarkan interaksi individu dengan sistem pendidikan, sistem kesehatan dan faktor masyarakat yang berkaitan dengan literasi kesehatan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Literasi kesehatan pada bidang sistem kesehatan berfokus pada partisipasi konsumen bisa sistem kesehatan yang berorientasi untuk mendukung kemitraan (Cox et al., 2014). Hal ini juga dapat berkontribusi mengurangi kesenjangan dalam layanan dan hasil kesehatan.

Literasi kesehatan pada bidang sistem pendidikan bertujuan untuk mengajarkan keterampilan literasi kesehatan dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan, pada bidang sosial dan budaya literasi kesehatan berfokus pada pemberian informasi terkait intervensi yang perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kesehatan literasi diterapkan pada individu sesuai dengan faktor pribadi, sosial, faktor lingkungan dan budaya (Cox et al., 2014).

E. Manfaat Literasi Kesehatan

Manfaat literasi kesehatan tidak hanya dapat dirasakan oleh konsumen atau individu yang bekerja di sistem kesehatan. Namun, manfaat literasi kesehatan dapat digunakan dalam beberapa peran. Pada tabel 3.1 dapat dilihat manfaat literasi kesehatan pada peran konsumen, penyedia layanan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, eksekutif pelayanan kesehatan dan anggota dewan serta pembuat kebijakan.

Tabel 3.1 Manfaat Untuk Menangani Literasi Kesehatan

No.	Wewenang	Manfat Literasi Kesehatan
1.	Konsumen	a. Memudahkan kemana dan bagaimana menemukan layanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. b. Membantu membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan, kesejahteraan dan layanan kesehatan. c. Memudahkan dalam mengelola layanan kesehatan individu dan keluarga, termasuk mempertahankan pengobatan dan rejimen pengobatan d. Membantu berkontribusi lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan tindakan terkait informasi kesehatan, penyediaan, perencanaan atau evaluasi.
2.	Penyedia Layanan Kesehatan	a. Membantu memberikan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan dan keinginan dari pasien dan keluarganya, dengan cara yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti. b. Membantu tenaga kesehatan untuk bekerja secara bersama dengan pasien

	dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat dan membuat keputusan yang efektif untuk kesehatan dan layanan kesehatan. c. Membantu mengubah pemberian layanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses, dipahami dan menggunakan informasi yang diberikan. d. Membantu mengurangi risiko bahaya bagi pasien dan keluarga dengan cara meningkatkan hubungan komunikasi interpersonal dan pertukaran informasi.
3. Manajer Pelayanan Kesehatan	a. Membantu saya mengatur cara penyampaian layanan kesehatan agar lebih mudah bagi konsumen untuk mengambil tindakan yang tepat dan membuat keputusan yang efektif untuk mereka kesehatan dan perawatan kesehatan b. Membantu memudahkan menemukan layanan kesehatan yang tersedia. c. Membantu memudahkan konsumen dalam mengakses dengan jelas, fokus dan jelas terkait informasi kesehatan dan layanan kesehatan. d. Membantu meningkatkan keterlibatan konsumen dengan layanan kesehatan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan kesehatan saya e. Membantu mengurangi risiko bahaya bagi pasien dan keluarga dengan cara meningkatkan hubungan komunikasi interpersonal dan pertukaran informasi.
4. Eksekutif Pelayanan Kesehatan	a. Membantu memastikan bahwa layanan kesehatan memahami dan melayani

dan Anggota Dewan	sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. b. Membantu memahami dan memberikan keselamatan dan kualitas kepada konsumen dalam pelayanan kesehatan dengan mendorong konsumen terlibat dalam pengambilan keputusan. c. Membantu meningkatkan pengalaman dan hasil layanan kesehatan dengan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan pilihan konsumen. d. Membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan layanan kesehatan efektif dan sesuai dengan tujuannya e. Membantu memberikan dukungan dan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan layanan kesehatan. f. Membantu meyakinkan bahwa konsumen memberikan persetujuan.
5. Kebijakan Kesehatan	a. Membantu memastikan bahwa sistem kesehatan terorganisir dan perawatan sedemikian rupa sehingga memudahkan konsumen untuk mengambil tindakan dan tindakan yang tepat keputusan yang efektif untuk kesehatan dan layanan kesehatan. b. Membantu memudahkan konsumen dalam mengakses dengan jelas, fokus dan dapat digunakan informasi kesehatan. c. Membantu memberikan dukungan dan lingkungan yang kondusif untuk kemitraan antara penyedia layanan kesehatan, organisasi layanan kesehatan dan konsumen.

-
- d. Meningkatkan keselamatan dan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan memberdayakan konsumen untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.
-

Sumber: (Cox et al., 2014)

F. Klasifikasi Literasi Kesehatan

Menurut (Retmana, 2022), konstruksi literasi kesehatan mencakup tiga elemen besar:

1. Pengetahuan tentang kesehatan, perawatan kesehatan dan sistem kesehatan;
2. Memproses dan menggunakan informasi dalam berbagai format terkait kesehatan dan perawatan kesehatan;
3. Kemampuan memelihara kesehatan dan mengamalkannya dalam lingkungan sosial.

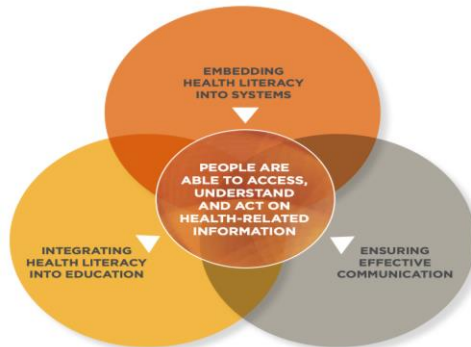
Literasi kesehatan menggambarkan keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan orang untuk mendapatkan akses kesehatan, memahami dan menerapkan informasi kesehatan untuk secara positif memengaruhi kesehatan mereka sendiri dan kesehatan orang-orang di lingkungan sosial mereka (Conard, 2019). Menurut (Nutbeam & Kickbucsh, 2000), menyoroti pentingnya untuk mencapai literasi kesehatan pada tingkat fungsional, interaktif, dan tingkat kritis (Nutbeam & Kickbucsh, 2000) terdiri dari:

1. Fungsional adalah penggunaan keterampilan literasi umum seperti membaca dan menulis untuk memahami pesan kesehatan dasar.
2. Interaktif berfokus pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi untuk pencegahan dan Manajemen diri.

3. Kritis, menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk mengatasi hambatan kesehatan dengan baik, sehingga membingkai literasi kesehatan sebagai sosial, hasilnya akan sangat berlawanan dengan kemampuan awal.

G. Tingkatan Literasi Kesehatan

Tingkat melek kesehatan individu yang rendah dikaitkan dengan tingkat kerugian yang lebih tinggi. Literasi kesehatan yang rendah juga terkait dengan penggunaan pendekatan preventif yang lebih rendah. Literasi kesehatan yang rendah secara signifikan dapat menguras manusia dan sumber daya keuangan yang dimiliki, serta mungkin terkait dengan biaya tambahan sekitar 3–5% untuk sistem kesehatan. Pada orang tua, literasi kesehatan individu yang rendah dikaitkan dengan status kesehatan yang lebih buruk dan dengan risiko yang lebih tinggi kematian dini. Ini menunjukkan usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis dan status kesehatan turut berpengaruh. Hambatan literasi kesehatan lebih besar hambatan bagi orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang berbicara bahasa selain bahasa yang biasa digunakan atau yang memiliki disabilitas. Program yang menargetkan melek kesehatan mungkin menawarkan titik masuk yang efektif untuk intervensi (Agarwal et al., 2020; De Gani et al., 2020; Trezona et al., 2018). Koordinasi literasi kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.4 Koordinasi Literasi Kesehatan

Sumber: (Cox et al., 2014)

H. Tindakan Literasi Kesehatan

Ada tiga tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani literasi kesehatan dengan cara yang terkoordinasi dengan cara (Greaney et al., 2020):

1. Menanamkan literasi kesehatan ke dalam system.
Melibatkan pengembangan dan penerapan system dan kebijakan di tingkat organisasi dan masyarakat yang mendukung tindakan untuk menangani literasi kesehatan. Ini sistem dapat mencakup perubahan mekanisme pendanaan untuk mendorong kesadaran dan tindakan tentang literasi kesehatan, menerapkan kebijakan yang mengutamakan literasi kesehatan dalam perencanaan program, dan merancang perawatan kesehatan organisasi dengan cara yang memudahkan orang untuk menemukan jalan mereka.
2. Memastikan komunikasi yang efektif
Melibatkan penyediaan cetakan, elektronik atau lainnya komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini juga melibatkan dukungan yang efektif kemitraan,

komunikasi dan interpersonal hubungan antara konsumen, penyedia layanan kesehatan, manajer, staf administrasi dan lain-lain.

3. Mengintegrasikan literasi kesehatan ke dalam pendidikan

Melibatkan mendidik konsumen dan perawatan kesehatan penyedia dan dapat mencakup kesehatan penduduk program, promosi kesehatan dan strategi pendidikan, pendidikan kesehatan sekolah, dan pemasaran sosial kampanye serta pendidikan dan pelatihan formal penyedia layanan kesehatan.

Setiap orang dapat berperan dalam menangani literasi kesehatan. Sangat penting bagi orang atau organisasi yang bekerja di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa lingkungan literasi kesehatan dapat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Beberapa tindakan yang dapat diambil oleh organisasi dan individu yang bekerja di sektor kesehatan, informasi tentang tindakan tambahan, termasuk yang dapat dilakukan oleh konsumen, konsumen kelompok, organisasi pendidikan dan pelatihan serta Pemerintah, pendamping, dan organisasi swasta tersedia pada Tabe1 dibawah ini (Liu et al., 2020). Tindakan yang diambil dalam sistem kesehatan untuk menangani literasi kesehatan, dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tindakan Untuk Menangani Literasi Kesehatan

No.	Wewenang	Tindakan Yang Mungkin Dilakukan
1.	Konsumen	a. Diskusikan dengan penyedia layanan kesehatan setiap kesulitan dalam memahami informasi dan layanan kesehatan. b. Mintalah bantuan pada keluarga, teman atau layanan dukungan (seperti layanan penerjemahan) kesulitan komunikasi. c. Mintalah informasi lebih lanjut tentang bagian perawatan yang tidak jelas. d. Bersikaplah terbuka dan jujur dengan penyedia layanan kesehatan tentang riwayat medis dan pengobatan. e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan berpartisipasi dalam pendidikan. f. Meningkatkan kesadaran di antara keluarga, teman, dan komunitas tentang pentingnya literasi kesehatan. g. Terlibat dalam perencanaan, desain dan penyampaian informasi dan layanan kesehatan untuk.
2.	Penyedia Layanan Kesehatan	a. Mengenali kebutuhan dan preferensi masing-masing pasien dan konsumen serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi orang tersebut. b. Asumsikan bahwa kebanyakan orang akan mengalami kesulitan untuk memahami dan menerapkan kesehatan yang kompleks informasi dan konsep. c. Gunakan berbagai strategi komunikasi antar pribadi untuk memastikan

	informasi telah disampaikan dan diterima secara efektif.
	d. Mendorong orang untuk berbicara jika mereka mengalami kesulitan memahami informasi yang diberikan
	e. Gunakan cara mengkomunikasikan informasi risiko tentang pilihan pengobatan kepada orang-orang yang dikenal menjadi efektif.
	f. Berpartisipasi dalam proyek perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi hambatan literasi kesehatan di lingkungan fisik organisasi kesehatan.
	g. Berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan literasi kesehatan, jika tersedia.
3. Organisasi Yang Menyediakan Kesehatan	a. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan proses literasi kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi literasi kesehatan tuntutan materi informasi, lingkungan fisik dan jalur perawatan local. b. Menyediakan dan mendukung akses ke literasi kesehatan dan pelatihan komunikasi interpersonal untuk penyedia layanan kesehatan, termasuk metode pelatihan dalam mengkomunikasikan risiko. c. Menyediakan program pendidikan bagi konsumen yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kesehatan organisasi.
4. Dukungan Penyedia Kesehatan	a. Memimpin dan mengkoordinasikan tindakan literasi kesehatan dalam profesinya.

	b. Kembangkan kebijakan dan pernyataan posisi tentang literasi kesehatan. c. Mendorong dan mendukung peluang pengembangan profesional dan memengaruhi program pendidikan untuk penyedia layanan kesehatan dalam komunikasi, literasi kesehatan, dan praktik yang berpusat pada pasien secara umum. d. Berkolaborasi di seluruh sektor perawatan kesehatan pada aktivitas literasi kesehatan, termasuk strategi berbagi dan pembelajaran lintas dan antara profesi dan sektor.
5. Kebijakan Kesehatan	a. Meningkatkan kesadaran tentang masalah literasi kesehatan. b. Menanamkan prinsip literasi kesehatan ke dalam pengembangan kebijakan kesehatan. c. Mendukung desain dan penyampaian kebijakan, jalur, dan proses yang mengurangi kompleksitas yang terlibat dalam menavigasi sistem kesehatan termasuk lintas sektor dan pengaturan. d. Jelajahi peluang untuk memasukkan implementasi strategi untuk menangani literasi kesehatan sebagai inti.
6. Organisasi Swasta	a. Bekerja secara kolaboratif di semua tingkat pemerintahan untuk mempromosikan tindakan terkoordinasi tentang literasi kesehatan. b. Mengadvokasi pendanaan dan alokasi sumber daya untuk inisiatif literasi kesehatan.

-
- c. Menerapkan, mengevaluasi dan berbagi informasi tentang program literasi kesehatan.
 - d. Mengembangkan kemitraan untuk memfasilitasi pertukaran informasi tentang penelitian literasi kesehatan dan program antara komunitas penelitian dan praktik.
-

Sumber: (Liu et al., 2020)

Selain sasaran, faktor penting yang harus diperhatikan dalam intervensi kesehatan adalah instrumen yang digunakan untuk meyakini bahwa perubahan perilaku sasaran terjadi karena intervensi kesehatan yang diberikan. Instrumen tersebut harus objektif, artinya pengukuran berbasis tes mengacu pada tes objektif (dimana hasilnya benar atau salah) dan menjelaskan keterampilan absolut yang tidak terkait dengan konteks/ lingkungan; ukuran laporan diri mengacu pada persepsi individu tentang literasi kesehatan mereka sendiri (di mana hasilnya dilaporkan dalam skala), yang akan mencerminkan keseimbangan antara keterampilan dan konteks/ lingkungan. Perlu adanya media literasi kesehatan yang dapat mencakup skala nasional sehingga dapat berlaku umum dan berdaya guna bagi sasaran yang sama (Ridgway et al., 2020). *The Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (the Commission)* membagi literasi kesehatan dalam dua komponen, yaitu (Greenfield et al., 2015):

1. Keterampilan, pengetahuan, motivasi dan kapasitas seseorang untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif tentang kesehatan dan perawatan kesehatan serta mengambil tindakan yang tepat.

2. infrastruktur, kebijakan, proses, material, orang dan hubungan yang membentuk kesehatan, sistem dan berdampak pada cara orang mengakses, memahami, menilai dan menerapkan yang berhubungan dengan kesehatan informasi dan layanan.

Dua Konsep baru dalam dunia literasi kesehatan yang dikembangkan pada 3 tahun terakhir (Conard, 2019; Sastre et al., 2019):

1. Literasi kesehatan digital.

Konsep ini semakin menarik perhatian karena kemajuan teknologi digital dan potensinya sebagai metode komunikasi informasi yang penting untuk "membuat penilaian dan mengambil keputusan (untuk kesehatan) dalam kehidupan sehari-hari". Definisi yang banyak digunakan menyatakan bahwa literasi kesehatan digital adalah "kemampuan untuk mencari, menemukan, memahami, dan menilai informasi kesehatan dari sumber elektronik dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi atau memecahkan masalah kesehatan (Trezona et al., 2018). Pendekatan berbasis pengembangan teknologi media dalam literasi kesehatan bertujuan untuk penyederhanaan literasi kesehatan, penyebaran literasi kesehatan, pengembangan pemahaman dan perilaku kesehatan yang dapat terus ada tanpa batasan waktu. Teknologi media memberikan kesempatan kepada individu untuk mandiri dalam menentukan kesehatannya. Solusi media teknologi memungkinkan penyampaian literasi kesehatan melalui multi-media, seperti video, suara, dan teks.

2. Literasi kesehatan mental

Konsep ini berkembang secara terpisah dari bidang literasi kesehatan yang lebih luas. Definisi awal difokuskan pada pengetahuan, sikap dan kepercayaan masyarakat tentang gangguan mental yang akan membantu pengenalan, manajemen atau pencegahan mereka. Seperti dalam bidang literasi kesehatan yang lebih luas, definisi tersebut telah berkembang dengan memasukkan keterampilan untuk memperoleh dan memelihara kesehatan mental yang positif dan mencari bantuan kesehatan mental bila diperlukan (Huang et al., 2020; Stock et al., 2021). Hasil dari kegiatan literasi kesehatan mental, dan karenanya indikator perubahan yang dipelajari dan alat yang digunakan untuk menunjukkan perubahan itu, dapat sangat bervariasi sesuai dengan definisi literasi kesehatan mental yang digunakan oleh studi tertentu. Beberapa studi hanya akan fokus pada pengetahuan, sikap dan keyakinan tentang kesehatan mental, sementara yang lain akan memasukkan elemen kapasitas kesehatan mental (Holt et al., 2020).

Bab 4

Stroke

A. Pengertian Stroke

Stroke didefinisikan sebagai gangguan neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem arteri serebral (Price and Wilson, 2006). Menurut Caplan (2016), stroke adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan cedera otak yang disebabkan oleh abnormalitas aliran darah ke suatu bagian di otak. Penyakit stroke menyangkut semua proses patologi yang mengenai pembuluh darah otak. Sebagian besar penyakit pembuluh darah otak disebabkan oleh trombotik, emboli, atau hemoragik. Mekanisme masing-masing etiologi ini berbeda, tetapi akibatnya sama yaitu iskemia atau hipoksia pada area otak setempat. Iskemia dan hipoksia dapat menyebabkan nekrosis otak (infark) (Caplan, 2016).

B. Jenis Stroke

Menurut Giraldo, (2007), penyebab stroke dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Stroke non hemoragik (stroke iskemik)

Stroke iskemik adalah kematian suatu area otak yang disebabkan oleh tidak mencukupinya aliran darah dan oksigen ke otak akibat sumbatan arteri serebral. Stroke iskemik berdasarkan penyebab sumbatan arteri

dibagi menjadi tiga yaitu stroke trombolitik, stroke embolik dan infark lakunar (Giraldo, 2007)

2. Stroke Hemoragik

Stroke hemoragik adalah perdarahan yang terjadi didalam jaringan otak atau di ruang sub araknoid, stroke hemoragik disebabkan oleh hipertensi kronik dan kelainan arteri serebral yang menyebabkan lemahnya arteri, sehingga pada suatu kondisi dapat menyebabkan pecahnya arteri serebral. Pecahnya arteri serebral menyebabkan akumulasi darah intraserebral atau dalam ruang sub araknoid. Terdapat dua tipe utama stroke hemoragik berdasarkan perdarahan yang terjadi, yaitu hemoragik intraserebral dan hemoragik subaraknoid.

C. Etiologi Stroke

Menurut (Kementerian Kesehatan RI, 2019), etiologi stroke dikarenakan adanya gangguan aliran darah yang menyebabkan stroke. Gangguan aliran darah ini dapat disebabkan oleh penyempitan atau tertutupnya salah satu pembuluh darah ke otak dan hal ini terjadi karena:

1. Trombosis serebral yang diakibatkan adanya atherosclerosis, umumnya menyerang usia lanjut. Thrombosis biasanya terjadi pada pembuluh darah saat oklusi terjadi. Thrombosis ini dapat menyebabkan iskemik jaringan otak, edema serta kongesti diarea sekitarnya. Thrombus yang menyebabkan stroke biasanya terjadi saat tidur atau setelah bangun tidur.
2. Emboli serebral, merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak atau udara. Umumnya emboli berasal dari thrombus di jantung yang terlepas kemudian menyumbat sistem arteri serebral.

Gejala pada emboli pada cerebra umumnya berlangsung sekitar 10-30 detik dan berlangsung cepat.

3. Peredaran intra serebral, terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak. Pecahnya pembuluh darah otak akan menyebabkan merembesnya darah kedalam parenkim otak yang dapat mengakibatkan penekanan, penggeseran, dan pemisahan jaringan otak yang berdekatan dan berakibat otak akan membengkak

D. Faktor Risiko Stroke

Menurut (Sari, 2019), ragam faktor risiko stroke yang harus diwaspadai beberapa diantaranya adalah:

1. Pernah terserang stroke

Seseorang yang pernah mengalami stroke, termasuk transient ischaemic attack (TIA) atau stroke ringan, rentan terserang stroke berulang. Seseorang yang pernah mengalami TIA yang berlangsung singkat akan sembilan kali lebih berisiko mengalami stroke dibanding yang tidak pernah mengalami TIA.

2. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah faktor risiko tunggal yang paling sering untuk stroke iskemik maupun stroke perdarahan. Pada keadaan hipertensi, pembuluh darah mendapat tekanan yang cukup besar. Apabila proses tekanan berlangsung lama, dapat menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah, sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Hipertensi juga dapat menyebabkan aterosklerosis atau penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, sehingga mengganggu aliran darah ke jaringan otak.

3. Penyakit jantung
Beberapa penyakit jantung, seperti fibrilasi atrial (salah satu jenis gangguan irama jantung), penyakit jantung koroner, penyakit jantung rematik, dan orang yang melakukan pemasangan katup jantung buatan akan meningkatkan risiko stroke.
4. Diabetes mellitus (DM)
Seseorang dengan diabetes rentan untuk menjadi aterosklerosis, hipertensi, obesitas, dan gangguan lemak darah. Seseorang yang mengidap diabetes mempunyai risiko serangan stroke iskemik 2 kali lipat dibanding mereka yang tidak diabetes.
5. Kolesterol Tinggi
Kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia dapat menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis sendiri berperan dalam menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke.
6. Merokok
Perokok dilaporkan lebih rentan mengalami stroke dibandingkan bukan perokok. Nikotin dalam rokok dapat membuat jantung bekerja keras karena frekuensi denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Nikotin juga bisa mengurangi kelenturan arteri serta dapat menimbulkan aterosklerosis.
7. Gaya hidup tidak sehat
Diet tinggi lemak, aktivitas fisik minim, serta stres emosional dapat meningkatkan risiko seseorang terkena stroke. Seseorang yang sering mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kurang melakukan aktivitas fisik rentan mengalami obesitas, diabetes mellitus, aterosklerosis, penyakit jantung dan stroke.

8. Usia

Usia adalah faktor risiko stroke yang tidak dapat dikontrol atau dimodifikasi. Padahal, risiko seseorang mengalami stroke dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Risiko semakin meningkat ketika setelah seseorang menginjak usia 55 tahun. Usia terbanyak orang terkena serangan stroke adalah 65 tahun ke atas. Menurut (Dharma et al., 2018), dari 2.065 pasien stroke akut yang dirawat di 28 Rumah Sakit di Indonesia, 35,8 % berusia di atas 65 tahun dan 12,9 % kurang dari 45 tahun.

9. Jenis kelamin

Stroke dilaporkan menyerang laki-laki 19 persen lebih banyak dibandingkan wanita. Meski demikian, baik pria maupun wanita tetap harus mewaspadai penyakit mematikan ini (Sofyan et al., 2013).

10. Keturunan

Risiko stroke akan meningkat jika ada orangtua atau saudara kandung yang lebih mengalami stroke maupun TIA

E. Patofisiologi Stroke

Menurut (Kuriakose & Xiao, 2020), patotofisiologi stroke dapat diuraikan sebagai berikut: otak sangat tergantung kepada oksigen, bila terjadi anoksia seperti yang terjadi pada stroke di otak mengalami perubahan metabolik, kematian sel dan kerusakan permanen yang terjadi dalam 3 sampai dengan 10 menit (non aktif total). Pembuluh darah yang paling sering terkena ialah arteri serebral dan arteri karotis interna. Adanya gangguan peredaran darah otak dapat menimbulkan jejas atau cedera pada otak melalui empat mekanisme, yaitu:

1. Penebalan dinding arteri serebral yang menimbulkan penyempitan sehingga aliran darah dan suplainya ke sebagian otak tidak adekuat, selanjutnya akan mengakibatkan perubahan-perubahan iskemik otak;
2. Pecahnya dinding arteri serebral akan menyebabkan bocornya darah ke jaringan (hemorrhage);
3. Pembesaran sebuah atau sekelompok pembuluh darah yang menekan jaringan otak;
4. Edema serebri yang merupakan pengumpulan cairan di ruang interstitial jaringan otak.

Konstriksi lokal sebuah arteri mula-mula menyebabkan sedikit perubahan pada aliran darah dan baru setelah stenosis cukup hebat dan melampaui batas kritis terjadi pengurangan darah secara drastis dan cepat. Oklusi suatu arteri otak akan menimbulkan reduksi suatu area dimana jaringan otak normal sekitarnya yang masih mempunyai pendarahan yang baik berusaha membantu suplai darah melalui jalur-jalur anastomosis yang ada. Perubahan awal yang terjadi pada korteks akibat oklusi pembuluh darah adalah gelapnya warna darah vena, penurunan kecepatan aliran darah dan sedikit dilatasi arteri serta arteriole. Selanjutnya akan terjadi edema pada daerah ini. Selama berlangsungnya peristiwa ini, autoregulasi sudah tidak berfungsi sehingga aliran darah mengikuti secara pasif segala perubahan tekanan darah arteri. Berkurangnya aliran darah serebral sampai ambang tertentu akan memulai serangkaian gangguan fungsi neural dan terjadi kerusakan jaringan secara permanen.

F. Manifestasi Klinik Stroke

Secara umum gejala stroke meliputi:

1. Defisit neurologik

Defisit neurologi yang terjadi secara mendadak seperti kelemahan otot wajah, kelemahan otot lengan dan tungkai terutama pada salah satu sisi tubuh. Hemiparesis (kelemahan) dan hemiplegia (paralisis) yang terjadi pada salah satu sisi tubuh lazim terjadi setelah serangan stroke. Kedua gejala ini sering disebabkan oleh sumbatan arteri serebral anterior dan media yang menimbulkan infark pada area motorik korteks frontal. Hemiparesis dan hemiplegia terjadi secara kontralateral. Infark pada area motorik korteks sebelah kanan menyebabkan hemiplegia sebelah kiri atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena serabut saraf saling menyilang pada traktus pyramidal (Griggs et al., 2019).

2. Kehilangan kemampuan bicara atau memahami pembicaraan (Afasia)

Afasia adalah defisit kemampuan berkomunikasi. Afasia dapat merusak beberapa atau semua aspek kemampuan komunikasi seperti berbicara, membaca, menulis dan memahami bahasa orang lain. Afasia terjadi karena sumbatan arteri serebral media yang menyebabkan infark pada hemisfer kiri serebral. Afasia umumnya berhubungan dengan hemiplegia, yaitu mencakup hemisfer dominan. Pasien dengan tangan kanan dominan memiliki pusat bicara pada hemisfer kiri serebral atau sebaliknya. Sehingga pada pasien dengan tangan kanan dominan yang mengalami hemiplegia kanan biasanya mengalami afasia karena infark yang terjadi pada hemisfer kiri serebral juga menyebabkan rusaknya fungsi bicara (Azizi et al., 2020).

3. Gejala lainnya antara lain artikulasi yang tidak sempurna (disartria), gangguan penglihatan, mulut pelo, hilangnya keseimbangan atau koordinasi tubuh, gangguan menelan, gangguan memori dan nyeri kepala mendadak (Ifejika et al., 2019).

G. Pengelolaan Stroke

1. Pengawasan

World Health Organization (WHO) merekomendasikan pendekatan pengawasan stroke bertahap (STEPS Stroke) untuk mengumpulkan data dan memantau tren. STEPS Stroke merekomendasikan pengumpulan tiga jenis data: informasi pasien stroke yang dirawat di fasilitas kesehatan (langkah 1), jumlah kejadian stroke fatal di masyarakat (langkah 2), dan perkiraan jumlah kejadian stroke non-fatal di masyarakat (langkah 3). Sebuah studi yang menggabungkan surveilans STEPS Stroke di sembilan lokasi di India, Republic of Iran, Mozambique, Nigeria dan Rusia menunjukkan bahwa pengasawan STEPS Stroke dimungkinkan dan layak untuk dilakukan (Truelsens et al., 2007).

2. Skrining untuk Populasi Berisiko Tinggi untuk Stroke

Skrining untuk faktor risiko stroke memberikan kesempatan yang sangat baik untuk mengidentifikasi dan mendidik mereka yang berisiko tinggi. Biasanya mencakup survei informasi demografi dan gaya hidup, pengukuran tekanan darah, deteksi stenosis arteri karotis, pengukuran kolesterol, pengukuran glukosa darah dan pendidikan tentang tanda atau gejala peringatan, seperti serangan stroke ringan, dan gejala yang berhubungan dengan penyakit jantung, seperti fibrilasi atrium (Yan et al., 2016). Pada tingkat yang paling dasar, skrinning untuk

faktor risiko dapat mencakup pengumpulan informasi tentang demografi dan gaya hidup, seperti diet, aktivitas fisik, merokok dan penggunaan alkohol. Skrining tingkat kedua mungkin mencakup data yang diperoleh dari pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar, dan tekanan darah. Tingkat terakhir termasuk tindakan laboratorium, seperti kadar glukosa darah dan kolesterol (Yan et al., 2016).

3. Diagnosis

The American Stroke Association memperkenalkan pedoman praktik terbaik untuk diagnosis stroke yang mencakup riwayat pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan skala stroke dan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan neurologis harus dilakukan jika riwayat pasien dan pemeriksaan fisik menunjukkan adanya stroke, dan National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) atau skala standar stroke lainnya dapat membantu dalam memperkirakan tingkat keparahan stroke. Pada pemeriksaan pencitraan otak dapat membedakan stroke iskemik dari perdarahan intrakranial, mengidentifikasi subtype stroke, dan seringkali penyebab stroke; pencitraan vaskular dapat mengidentifikasi lokasi dan penyebab obstruksi arteri serta pasien dengan risiko tinggi kekambuhan stroke. Pemindaian Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), USG Doppler, CT angiografi, angiografi resonansi magnetik juga banyak digunakan di HIC untuk menentukan subtype dan penyebab stroke. Strategi yang paling banyak digunakan untuk diagnosis stroke adalah CT scan segera (Yan et al., 2016).

H. Pencegahan Primer Stroke

1. Pengendalian tembakau

Pengendalian tembakau menduduki peringkat nomor satu di antara lima intervensi prioritas teratas untuk penyakit tidak menular (PTM). Menurut model simulasi mikro berdasarkan data di India, undang-undang bebas asap rokok dan pajak tembakau dapat mencegah 25% (95% CI: 17%-34%) infark miokard dan stroke (Beaglehole et al., 2011).

2. Pencegahan dan pengendalian darah tinggi.

Mengendalikan tekanan darah telah terbukti mengurangi risiko stroke secara efektif. Semua pedoman klinis dan pernyataan ahli kesehatan tentang pencegahan stroke sangat menekankan pada pencegahan dan pengendalian tekanan darah tinggi (Yano et al., 2014).

3. Pengurangan natrium

Pengurangan asupan natrium telah menduduki peringkat sebagai intervensi yang menghemat biaya kedua, setelah pengendalian tembakau untuk mengatasi krisis penyakit tidak menular (PTM) (Beaglehole et al., 2011).

4. Farmasi

Selain memodifikasi gaya hidup, strategi lain yang harus ditekankan dalam pencegahan primer adalah melalui sarana farmasi untuk mengatasi hipertensi, dislipidemia, dan fibrilasi atrium (Kirkman et al., 2018).

5. Program pendidikan masyarakat

Pendidikan masyarakat mencakup semua pendekatan yang berkaitan dengan penyaringan, peningkatan kesadaran, pendidikan kesehatan tentang faktor-faktor risiko, cara-cara untuk mengurangi risiko penyakit, dan

kegiatan promosi kesehatan lainnya yang dilakukan di masyarakat (Yan et al., 2016).

6. Pencegahan melalui strategi kesehatan berbasis digital
Kesehatan digital muncul sebagai bidang yang menjanjikan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baru untuk meningkatkan manajemen perawatan kesehatan bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien. Program kesehatan digital memiliki potensi untuk memperluas akses ke layanan pencegahan dan pengobatan yang diperlukan menggunakan infrastruktur komunikasi yang ada di mana-mana dan berbiaya rendah (Colantonio et al., 2010).

Bab 5

Penutup

Pemberdayaan keluarga melalui literasi kesehatan dalam pencegahan penyakit stroke merupakan langkah strategis yang mengedepankan edukasi, kesadaran, dan partisipasi aktif dari setiap anggota keluarga. Dalam perjalanan buku ini, kita telah membahas berbagai aspek yang menjadi fondasi penting dalam mencegah stroke, mulai dari memahami faktor risiko, menerapkan gaya hidup sehat, hingga peran teknologi dan komunitas dalam meningkatkan literasi kesehatan.

Penyakit stroke adalah tantangan kesehatan yang dapat dicegah dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong perilaku hidup sehat. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kebiasaan merokok, dan pola makan tidak sehat, keluarga dapat berperan aktif dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya stroke.

Melalui buku ini, kami telah menggarisbawahi pentingnya literasi kesehatan sebagai kunci utama dalam pemberdayaan keluarga. Literasi kesehatan tidak hanya mencakup kemampuan memahami informasi medis, tetapi juga melibatkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan

informasi tersebut. Dengan meningkatkan literasi kesehatan, keluarga mampu:

1. Mengenali gejala awal stroke dan bertindak cepat untuk mendapatkan pertolongan medis.
2. Membantu anggota keluarga yang memiliki risiko tinggi untuk mengelola kondisi kesehatan mereka.
3. Menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat dan bebas stres.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan stroke. Untuk memperkuat dampak pemberdayaan ini, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:

1. Edukasi Berkelanjutan

Penyelenggaraan program pendidikan kesehatan di tingkat keluarga dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman tentang stroke dan pencegahannya.

2. Kerja Sama dengan Layanan Kesehatan

Mendorong kolaborasi antara keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk pemantauan risiko secara rutin.

3. Penggunaan Teknologi

Memanfaatkan aplikasi kesehatan dan media digital sebagai alat bantu untuk edukasi dan pemantauan kesehatan.

4. Kebijakan yang Mendukung

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung pemberdayaan keluarga melalui kebijakan yang mempermudah akses terhadap informasi kesehatan dan layanan medis.

Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa pencegahan stroke adalah tanggung jawab bersama. Keluarga yang teredukasi dan terampil dalam mengelola risiko kesehatan akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan semangat kolaborasi, kepedulian, dan kesadaran, mari kita wujudkan masyarakat yang bebas dari ancaman stroke.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah mengikuti pembahasan dalam buku ini. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Anda dan keluarga.

Daftar Pustaka

- Agarwal, N., Funahashi, R., Taylor, T., Jorge, A., Feroze, R., Zhou, J., Hansberry, D. R., Gross, B. A., Jankowitz, B. T., & Friedlander, R. M. (2020). Patient Education and Engagement Through Multimedia: A Prospective Pilot Study on Health Literacy in Patients with Cerebral Aneurysms. *World Neurosurgery*, 138, e819–e826. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.03.099>
- Ardian, I. (2014, May). *Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Unissula, LII, 41–54.
- Artal, J. C., Egido, J. A., Gonzalez, J. L., & Seijas, V. (2000). Quality of life among stroke survivors evaluated 1 year after stroke: experience of stroke unit. *Journal of the American Heart Association*, 31, 2995–3000.
- Azizi, A., Khatiban, M., Mollai, Z., & Mohammadi, Y. (2020). Effect of Informational Support on Anxiety in Family Caregivers of Patients with Hemiplegic Stroke. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 29(9).
- Beaglehole, R., Bonita, R., Horton, R., Adams, C., Alleyne, G., Asaria, P., Baugh, V., Bekedam, H., Billo, N., Casswell, S., Cecchini, M., Colagiuri, R., Colagiuri, S., Collins, T., Ebrahim, S., Engelgau, M., Galea, G., Gaziano, T., Geneau, R., ... Watt, J. (2011). Priority actions for the non-communicable disease crisis. *The Lancet*, 377(9775), 1438–1447. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60393-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60393-0)
- Capacity Building Center for States. (2019). Family Empowerment Implementation Manual Family Empowerment Implementation Manual Family Empowerment 2 Acknowledgment. <https://learn.childwelfare.gov/>
- Chisholm-Burns, M. A., Spivey, C. A., & Pickett, L. R. (2018). Health literacy in solid-organ transplantation: A model to improve understanding. In *Patient Preference and Adherence* (Vol. 12,

pp. 2325–2338). Dove Medical Press Ltd.
<https://doi.org/10.2147/PPA.S183092>

- Colantonio, L. D., Martí, S. G., & Rubinstein, A. L. (2010). Economic evaluations on cardiovascular preventive interventions in Argentina. *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*, 10(4), 465–473. <https://doi.org/10.1586/erp.10.50>
- Conard, S. (2019). Best practices in digital health literacy. *International Journal of Cardiology*, 292, 277–279. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.05.070>
- Cox, D., Cuddihy, M., Hill, S., Horvat, L., Johnson, A., Luxford, K., Mitchell, I., Robinson, M., Walker, C., Webb, D., & Vanderhoek, V. (2014). *Health Literacy: Taking action to improve safety and quality*.
- De Gani, S. M., Nowak-Flück, D., Nicca, D., & Vogt, D. (2020). Self-assessment tool to promote organizational health literacy in primary care settings in switzerland. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249497>
- Demaerschalk, B. M., Hwang, H. M., & Leung, G. (2010). US Cost Burden of Ischemic Stroke: A Systematic Literature Review. *Am J Manag Care*, 16(7), 525–533.
- Dewi, R. K., & Sumarni, S. (2023). Parenting style and family empowerment for children's growth and development: a systematic review. *Journal of Public Health in Africa*, 14(S2). <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2582>
- Dharma, K. K., Damhudi, D., Yarden, N., & Haeriyanto, S. (2018). Increase in the functional capacity and quality of life among stroke patients by family caregiver empowerment program based on adaptation model. *International Journal of Nursing Sciences*, 5(4), 357–364. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.09.002>

- Dobkin, B. H. (2005). Rehabilitation after Stroke. *The New England Journal of Medicine*, 16(16), 77–84.
- Faster Capital. (2024). The Importance Of Empowering Families. <https://fastercapital.com/topics/the-importance-of-empowering-families.html/1>
- Fauziah, L. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi peserta JKN-KIS (BPJS kesehatan) bagi segmen PBP di KC Pekalongan. *Undergraduate Thesis Thesis, IAIN Pekalongan*.
- Giraldo, E. A. (2007). *Ischemic Stroke. Merck Manual*. Merck Sharp & Dohme Corp.
- Greaney, M. L., Wallington, S. F., Rampa, S., Vigliotti, V. S., & Cummings, C. A. (2020). Assessing health professionals' perception of health literacy in Rhode Island community health centers: A qualitative study. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09382-1>
- Greenfield, D., Hinchcliff, R., Banks, M., Mumford, V., Hogden, A., Debono, D., Pawsey, M., Westbrook, J., & Braithwaite, J. (2015). Analysing "big picture" policy reform mechanisms: The Australian health service safety and quality accreditation scheme. *Health Expectations*, 18(6), 3110–3122. <https://doi.org/10.1111/hex.12300>
- Griggs, R., Józefowicz, R. F., & Aminoff, M. J. (2019). *Approach to the patient with neurologic disease*. Goldman's Cecil Medicine.
- Hasanah, T., Sunarti Euis, M. S., & Krisnatuti Diah, M. S. (2015). PENGARUH PEMBERDAYAAN KELUARGA TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU MENGENAI PENGASUHAN ANAK USIA PRASEKOLAH. *Pekerjaan Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v13i1.30>
- Holt, K. A., Overgaard, D., Engel, L. V., & Kayser, L. (2020). Health literacy, digital literacy and eHealth literacy in Danish nursing students at entry and graduate level: A cross sectional study.

BMC Nursing, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00418-w>

Huang, C. L., Yang, S. C., & Chiang, C. H. (2020). The associations between individual factors, ehealth literacy, and health behaviors among college students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/ijerph17062108>

Ifejika, N. L., Bhadane, M., Cai, C., Noser, E. A., & Savitz, S. I. (2019). Cluster Enrollment: A Screening Tool for Stroke Risk Factors in Minority Women Caregivers. *Journal of the National Medical Association*, 111(3), 281–284. <https://doi.org/10.1016/j.jnma.2018.10.013>

Indonesia, P. P. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*.

Javadzade, H., Larki, A., Tahmasebi, R., & Reisi, M. (2018). A Theory-Based Self Care Intervention with the Application of Health Literacy Strategies in Patients with High Blood Pressure and Limited Health Literacy. A Protocol Study. *International Journal of Hypertension*.

Jones, C. A., Mawarni, S., King, K. M., Smith, M., Allu, S. O., & Campbell, N. (2011). Tackling Health Literacy: Adaptation of public hypertension educational Materials for an Indo-Asian Population in Canada. *BMC Public Health*, 11(24).

Kementerian Kesehatan RI. (2019). Hari Keluarga Nasional. *Kementerian Kesehatan*.

Kirkman, M. S., Mahmud, H., & Korytkowski, M. T. (2018). Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*, 47(1), 81–96. <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2017.10.002>

Kong, X., Huang, X., Zhao, M., Xu, B., Xu, R., Song, Y., Yu, Y., Yang, W., Zhang, J., Liu, L., Zhang, Y., Tang, G., Wang, B., Hou, F. F., Li, P.,

- Cheng, X., Zhao, S., Wang, X., Qin, X., ... Huo, Y. (2018). Platelet Count Affects Efficacy of Folic Acid in Preventing First Stroke. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), 2136–2146. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.02.072>
- Kuriakose, D., & Xiao, Z. (2020). Pathophysiology and Treatment of Stroke: Present Status and Future Perspectives. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(20), 7609. <https://doi.org/10.3390/ijms21207609>
- Kurniawati, N. D., Rihi, P. D., & Wahyuni, E. D. (2020). *Relationship of family and self efficacy support to the rehabilitation motivation of stroke patients*. 2427–2430.
- Liu, C., Wang, D., Liu, C., Jiang, J., Wang, X., Chen, H., Ju, X., & Zhang, X. (2020). What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis. In *Family Medicine and Community Health* (Vol. 8, Issue 2). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000351>
- López-Espuela, F., González-Gil, T., Amarilla-Donoso, J., Cordovilla-Guardia, S., Portilla-Cuenca, J. C., & Casado-Naranjo, I. (2018). Critical points in the experience of spouse caregivers of patients who have suffered a stroke. A phenomenological interpretive study. *PLOS ONE*, 13(4), e0195190. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195190>
- Louis R. Caplan. (2016). *Caplan's Stroke* (L. R. Caplan, Ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316095805>
- Mardhiyah, A., Panduragan, S. L., & Mediani, H. S. (2022). Reducing Psychological Impacts on Children with Chronic Disease via Family Empowerment: A Scoping Review. In *Healthcare* (Switzerland) (Vol. 10, Issue 10). MDPI. <https://doi.org/10.3390/healthcare10102034>
- Marlina', Badaruddin, Fikarwin, Z., & Lubis, R. (2020). Model of family health empowerment preventing stroke in Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh. *Journal of Physics: Conference Series*,

1460(1), 012076. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1460/1/012076>

- Martínez-Rico, G., Simón, C., Cañadas, M., & McWilliam, R. (2022). Support Networks and Family Empowerment in Early Intervention. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph19042001>
- Mei, Y.-X., Lin, B., Zhang, W., Yang, D.-B., Wang, S.-S., Zhang, Z.-X., & Cheung, D. S. K. (2020). Benefits finding among Chinese family caregivers of stroke survivors: a qualitative descriptive study. *BMJ Open*, 10(10), e038344. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038344>
- Nielsen-Bohlman, Lynn., Panzer, A. M. ., & Kindig, D. A. . (2004). *Health literacy: a prescription to end confusion*. National Academies Press.
- NSW Health. (2022, May 19). What is empowerment? 27. <https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/principles/Pages/empowerment.aspx>
- Nutbeam, D., & Kickbucsh, I. (2000). Advancing health literacy: a global challenge for the 21st century. *Health Promotion International*, 15.
- Parellang, A (2018). Home Care Nursing Aplikasi Praktik Berbasis Evidence Based, Yogyakarta : Andi.
- Patel, M. D., Tilling, K., & Lawrence, E. (2006). Relationships between long-term stroke disability, handicap and health-related quality of life. *Age and Ageing*, 35, 273–279.
- Price, J. A., Morris, Z. A., & Costello, S. (2018). The application of adaptive behaviour models: A systematic review. In *Behavioral Sciences* (Vol. 8, Issue 1). MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/bs8010011>
- Price, S. A. and W. L. M. (2006). *Pathophysiology: Clinical Concepts of Disease Processes. 6th Edition, Vol. 1*, (6th ed., Vol. 1). EGC.

- Prochaska, J. O. (2008). Decision Making in the Transtheoretical Model of Behavior Change. *Medical Decision Making*, 28(6), 845–849. <https://doi.org/10.1177/0272989X08327068>
- Retmana, I. (2022). Implementasi Dukungan Kebijakan Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Literasi Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.93>
- Ridgway, L., Hackworth, N., Nicholson, J. M., & McKenna, L. (2020). Working with families: A systematic scoping review of family-centred care in universal, community-based maternal, child, and family health services. *Journal of Child Health Care*, 25(2), 268–289. <https://doi.org/10.1177/1367493520930172>
- Sari, D. K. , D. R. , & D. W. (2019). Association between family support, coping strategies and anxiety in cancer patients undergoin chemotherapy at General Hospital in Medan, North Sumatera, Indonesia. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*.
- Sastre, L. R., Wright, L. D., & Haldeman, L. (2019). Use of Digital Photography With Newcomer Immigrant and Refugee Youth to Examine Behaviors and Promote Health. *Health Promotion Practice*, 20(5), 639–641. <https://doi.org/10.1177/1524839919863465>
- Scheffler, E., & Mash, R. (2020). Figuring it out by yourself: Perceptions of home-based care of stroke survivors, family caregivers and community health workers in a low-resourced setting, South Africa. *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine*, 12(1). <https://doi.org/10.4102/phcfm.v12i1.2629>
- Sofyan, A. M., Sihombing, I. Y., & Hamra, Y. (2013). Hubungan Umur, Jenis Kelamin, Dan Hipertensi Dengan Kejadian Stroke. *Medula: Jurnal Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo*, 1(1). <https://doi.org/10.33772/medula.v1i1.182>
- Sorensen, K., Broucke, S. Van, Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy andPublic Health; a

Systematic Review and Integration of Defenition and Models.
BMC Public Health, 12(80).

- Stock, S., Altin, S., Nawabi, F., Civello, D., Shukri, A., Redaelli, M., & Alayli, A. (2021). A cross-sectional analysis of health literacy: patient- versus family doctor-reported and associations with self-efficacy and chronic disease. *BMC Family Practice*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12875-021-01527-4>
- Tang, Y. H., Pang, S. M. C., Chan, M. F., Yeung, G. S. P., & Yeung, V. T. (2008). Health Literacy, Complication Awareness, and Diabetic Kontrol in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 74–83.
- Tassé, M. J., & Balboni, G. (2020). Theories and measurement of adaptive behavior. In *APA handbook of intellectual and developmental disabilities: Foundations* (Vol. 1). (pp. 425–450). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000194-016>
- Tavousi, M., Haeri-Mehrizi, A., Rakhshani, F., Rafiefar, S., Soleymanian, A., Sarbandi, F., Ardestani, M., Ghanbari, S., & Montazeri, A. (2020). Development and validation of a short and easy-to-use instrument for measuring health literacy: The Health Literacy Instrument for Adults (HELIA). *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08787-2>
- Trezona, A., Dodson, S., & Osborne, R. H. (2018). Development of the Organisational Health Literacy Responsiveness (Org-HLR) self-assessment tool and process. *BMC Health Services Research*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3499-6>
- Truelsen, T., Heuschmann, P., Bonita, R., Arjundas, G., Dalal, P., Damasceno, A., Nagaraja, D., Ogunniyi, A., Oveisgharan, S., Radhakrishnan, K., Skvortsova, V., & Stakhovskaya, V. (2007). Standard method for developing stroke registers in low-income and middle-income countries: experiences from a feasibility study of a stepwise approach to stroke surveillance (STEPS

- Stroke). *The Lancet Neurology*, 6(2), 134–139. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(06\)70686-X](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70686-X)
- Veras, M., Stewart, J., Deonandan, R., Tatmatsu-Rocha, J. C., Higgins, J., Poissant, L., & Kairy, D. (2020). Cost Analysis of a Home-Based Virtual Reality Rehabilitation to Improve Upper Limb Function in Stroke Survivors. *Global Journal of Health Science*, 12(2), 98. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n2p98>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A 'missing' family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 085201. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wallace, A. (2010). Low Health Literacy; Overview, Assessment, and Steps Toward Providing High-Quality Diabetes Care. *Diabetes Spectrum*, 23(4), 220–227.
- WHO. (2024, September). *What you need to know about literacy*. <https://www.unesco.org/en/literacy/need-know>
- Willens, D. E., Kripalani, S., Schildcrout, J. S., Cawthon, C., Wallston, K., Mion, L. C., & R., & C. L. (2013). Association of Brief Health Literacy Screening and Blood Pressure in Primary Care. *Journal of Health Communication*.
- Yan, L. L., Li, C., Chen, J., Miranda, J. J., Luo, R., Bettger, J., Zhu, Y., Feigin, V., O'Donnell, M., Zhao, D., & Wu, Y. (2016). Prevention, management, and rehabilitation of stroke in low- and middle-income countries. *ENeurologicalSci*, 2, 21–30. <https://doi.org/10.1016/j.ensci.2016.02.011>
- Yano, Y., Briasoulis, A., Bakris, G. L., Hoshida, S., Wang, J.-G., Shimada, K., & Kario, K. (2014). Effects of antihypertensive treatment in Asian populations: A meta-analysis of prospective randomized controlled studies (CARDiovascular protectionN group in Asia: CARNA). *Journal of the American Society of Hypertension*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.1016/j.jash.2013.09.002>

Youth.gov. (2024). Impact of Family Engagement.
<https://youth.gov/youth-topics/impact-family-engagement#:~:text=>

Glosarium

A

Afasia: gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengontrol kemampuan berbahasa.

Aterosklerosis: penyakit pembuluh darah yang terjadi ketika plak menumpuk di arteri, sehingga menyempit atau menebal dan menghambat aliran darah.

D

Diabetes Mellitus: penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi.

E

Emboli: kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh massa asing, seperti gumpalan darah, gelembung udara, atau gumpalan kolesterol.

F

Fibrial Atrial: gangguan irama jantung yang menyebabkan jantung berdetak tidak teratur dan cepat.

H

Hipertensi: kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi.

I

Infark: gangguan irama jantung yang menyebabkan jantung berdetak tidak teratur dan cepat.

K

Komprehensif: luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal.

L

Literasi: kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara, serta mengolah informasi dan pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari.

Literasi Kesehatan: kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan.

M

Morbiditas: angka kesakitan atau kondisi seseorang yang sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari normalnya.

Mortalitas: angka kematian atau jumlah kematian yang terjadi pada suatu populasi atau wilayah.

N

Nekrosis: bentuk cedera sel yang mengakibatkan kematian prematur sel-sel pada jaringan hidup dengan autolisis.

Nikotin: zat kimia yang bersifat adiktif dan terdapat dalam berbagai tumbuhan, terutama tembakau.

P

Prevalensi: ukuran yang menunjukkan proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam periode waktu tertentu.

S

Stroke: gangguan fungsi otak yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terhambat atau terputus.

Stroke Hemoragik: kondisi medis yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan.

Stroke Non Hemoragik: kondisi ketika fungsi otak terganggu secara tiba-tiba akibat berkurangnya aliran darah ke otak.

T

Transient Ischaemic Attack (TIA): kondisi medis yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu secara sementara.

Trombosis: kondisi ketika darah menggumpal di dalam pembuluh darah, yang dapat menghalangi aliran darah normal dan menyebabkan komplikasi serius.

Profil Penulis



Dr. H. Andi Parellangi., S.Kep., Ners., M. Kep., M.H. Lahir di Marioriwawo (Soppeng) 15 Desember 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis, dimulai jenjang D3 Keperawatan AKPER DEPKES Ujung Pandang lulus 1997, melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada FK UNHAS lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan FIK UNPAD konsentrasi keperawatan komunitas sekaligus kuliah S2 Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan FH

UNPAD lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan S3 di FKM UNHAS lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 sebagai Perawat di RSUD Abd. Wahab Syahrani Samarinda Kalimantan Timur hingga tahun 2002. Dosen di Poltekkes Kemenkes Kaltim dari tahun 2002 s.d 2023. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai Direktur dan Dosen mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Home Care Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional dan internasional baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta, reviewer Jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: parellangikaltim@gmail.com. achmdfsl@contoh.com

Profil Penulis



Bisepta Prayogi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Kediri, 16 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Ners Universitas Jember tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai Dosen di STIKes Patria Husada Blitar hingga tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bisepta87@gmail.com

Profil Penulis



Ria Roswita, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom Lahir di Jakarta, 17 Mei 1985.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui roswitaria@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya pemberdayaan keluarga dalam upaya pencegahan penyakit stroke melalui peningkatan literasi kesehatan. Stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan permanen atau bahkan kematian, tetapi banyak faktor risiko yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan melalui pengetahuan yang tepat tentang kesehatan.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar stroke, faktor risiko yang terkait, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan.

Dalam konteks pemberdayaan keluarga, buku ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan stroke. Keluarga bukan hanya sebagai pendukung dalam perawatan pasien stroke, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya stroke pada anggota keluarga. Melalui peningkatan literasi kesehatan, keluarga dapat lebih sadar dan aktif dalam mengelola gaya hidup sehat, mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini stroke, dan menjalankan pola hidup yang mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk menurunkan angka kejadian stroke melalui peningkatan literasi kesehatan keluarga.

Buku ini membahas tentang pentingnya pemberdayaan keluarga dalam upaya pencegahan penyakit stroke melalui peningkatan literasi kesehatan. Stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan permanen atau bahkan kematian, tetapi banyak faktor risiko yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan melalui pengetahuan yang tepat tentang kesehatan.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar stroke, faktor risiko yang terkait, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan.

Dalam konteks pemberdayaan keluarga, buku ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan stroke. Keluarga bukan hanya sebagai pendukung dalam perawatan pasien stroke, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya stroke pada anggota keluarga. Melalui peningkatan literasi kesehatan, keluarga dapat lebih sadar dan aktif dalam mengelola gaya hidup sehat, mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini stroke, dan menjalankan pola hidup yang mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Buku ini tidak hanya menyasar individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk menurunkan angka kejadian stroke melalui peningkatan literasi kesehatan keluarga.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-77-4



9

786347

097774